

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **equidad en salud** es uno de los principios fundamentales del sistema sanitario chileno y una prioridad transversal en todas las políticas públicas de salud. Implica garantizar que **todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, territorio, género o etnia**, tengan la misma oportunidad de alcanzar el nivel más alto posible de salud.

La **OPS/OMS** define la equidad como la ausencia de diferencias injustas y evitables en salud entre grupos poblacionales. En Chile, la equidad se considera el eje rector del **modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario**, que orienta la atención primaria y las políticas de protección financiera (GES, Ley Ricarte Soto).

En el contexto del **EUNACOM**, este tema tiene alta relevancia porque permite al médico general:

- Comprender los determinantes estructurales de desigualdad.
 - Aplicar estrategias de abordaje equitativo en APS.
 - Reconocer las políticas públicas que buscan reducir brechas.
 - Incorporar un enfoque ético y social en su práctica clínica.
-

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Equidad vs. igualdad

Concepto	Definición	Ejemplo
Igualdad	Ofrecer los mismos recursos a todos.	Todos reciben el mismo número de controles médicos.

Equidad	Asignar recursos según las necesidades individuales o comunitarias.	Las comunas rurales con mayor mortalidad infantil reciben más recursos sanitarios.
----------------	---	--

En salud pública, **equidad** significa que el acceso, la calidad y los resultados no dependan del nivel socioeconómico, género o localización geográfica.

2.2. Tipos de equidad

Tipo	Descripción	Ejemplo
Equidad en el acceso	Igual oportunidad de recibir atención ante igual necesidad.	Acceso a especialistas en zonas rurales mediante telemedicina.
Equidad en el uso	Uso de servicios proporcional a la necesidad.	Mayor frecuencia de controles crónicos en adultos mayores.
Equidad en los resultados	Igual probabilidad de recuperar o mantener la salud.	Igual sobrevida oncológica entre pacientes del sistema público y privado.
Equidad financiera	Pago proporcional a la capacidad económica.	FONASA subsidia a los tramos A y B.

2.3. Determinantes sociales de la inequidad

Los **determinantes sociales de la salud (DSS)**, según la **OMS**, son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Principales determinantes que generan **inequidad** en Chile:

- Nivel socioeconómico (pobreza, educación, empleo).
- Territorio (urbano vs. rural).

- Etnia y pertenencia cultural.
- Género.
- Acceso a redes y servicios públicos.

Ejemplo: la mortalidad infantil en comunas rurales de bajo ingreso puede duplicar la de comunas urbanas de altos recursos.

3. Situación epidemiológica y sanitaria en Chile (2024–2025)

Chile ha logrado **mejoras significativas en los indicadores globales de salud**, pero mantiene **brechas persistentes entre grupos socioeconómicos y territoriales**.

3.1. Datos actuales (DEIS, ENS y OPS 2024)

Indicador	Promedio nacional	Brecha social o territorial
Esperanza de vida	81,5 años	Diferencia de hasta 8 años entre comunas ricas y pobres.
Mortalidad infantil	6,7 por 1.000 nacidos vivos	Doble en comunas rurales y mapuches.
Obesidad en adultos	34 %	Mayor en zonas rurales y quintiles bajos.
Control hipertensivo efectivo	58 %	Menor cobertura en regiones extremas.
Acceso a especialistas	45 % de demora > 3 meses	Mayor lista de espera en el sistema público.

Tendencia:

Las brechas se han reducido lentamente, pero persisten especialmente en **zonas rurales, pueblos originarios, migrantes y población en pobreza multidimensional**.

4. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

4.1. Marco normativo

Norma o política	Año	Enfoque principal
Constitución Política de Chile	En revisión (2024)	Reconoce el derecho a la protección de la salud.
Ley N.º 18.469	1985	Regula el régimen de prestaciones y crea FONASA.
Ley N.º 20.584	2012	Derechos y deberes de las personas en salud.
Ley N.º 20.850 (Ley Ricarte Soto)	2015	Equidad en acceso a tratamientos de alto costo.
Estrategia Nacional de Salud 2021–2030	MINSAL	Reducción de desigualdades sanitarias.
Plan Nacional de Equidad de Género en Salud	2022	Igualdad de oportunidades sanitarias entre hombres y mujeres.

4.2. Programas y estrategias ministeriales

Programa	Objetivo	Nivel de aplicación
----------	----------	---------------------

Garantías Explícitas en Salud (GES)	Equidad en cobertura de 87 patologías prioritarias.	Sistema nacional (público y privado).
Estrategia de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario	Atención centrada en las personas, familias y comunidades.	Atención Primaria.
Programa de Salud Rural	Reducir brechas geográficas en acceso y calidad.	APS rural.
Ley Ricarte Soto	Protección financiera ante enfermedades de alto costo.	Nacional.
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)	Fortalecer continuidad asistencial y eficiencia territorial.	Servicios de Salud regionales.

5. Modelo de intervención y estrategias de acción

5.1. Enfoque de determinantes sociales

- **Prevención primaria:** actuar sobre condiciones de vida (educación, empleo, vivienda).
- **Prevención secundaria:** detección precoz de enfermedades (tamizajes en APS).
- **Prevención terciaria:** rehabilitación y reinserción social.

5.2. Estrategias de acción ministerial

1. **Descentralización sanitaria:** fortalecer el rol de los Servicios de Salud regionales.
2. **Telemedicina y salud digital:** reducir brechas de acceso geográfico.
3. **Plan de equidad rural e indígena:** incorporar pertinencia cultural en salud.

4. **Reducción de gasto de bolsillo:** mediante GES y Ley Ricarte Soto.
5. **Promoción intersectorial:** educación, trabajo, vivienda y medio ambiente.

5.3. Ejemplo práctico: tamizaje equitativo

El **tamizaje de cáncer cervicouterino** con PAP y test de VPH es gratuito en APS.

- Cobertura nacional: 64 %.
- Cobertura en zonas rurales: 45 %.

El enfoque equitativo busca implementar **estrategias móviles o comunitarias** para aumentar la cobertura en sectores de difícil acceso.

6. Rol del médico general y competencias en APS

El médico general es un **agente clave de equidad sanitaria**, pues actúa en el primer nivel de contacto con la población.

Rol	Ejemplo
Educador y promotor de salud	Adaptar mensajes a contextos culturales y educativos.
Identificador de barreras	Detectar causas sociales del no acceso (falta de transporte, horarios laborales).
Gestor comunitario	Participar en diagnósticos participativos locales.
Vigilante de derechos	Garantizar el acceso universal a controles y tratamientos GES.

Agente intersectorial

Coordinar con educación, municipio, organizaciones sociales.

El médico general en APS no solo atiende enfermedades: **disminuye inequidades y construye justicia sanitaria.**

7. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
Confundir equidad con igualdad	La equidad busca compensar desigualdades, no tratarlas igual.
Creer que la inequidad solo depende del sistema de salud	También surge de determinantes sociales externos (educación, vivienda).
Pensar que la equidad es un tema ético, no técnico	Tiene indicadores, metas y programas específicos.
Ignorar el rol de la APS	Es el principal nivel de intervención equitativa.
Desconocer que el GES y la Ley Ricarte Soto son políticas de equidad	Ambos garantizan cobertura universal en patologías prioritarias.

8. Complicaciones y desafíos actuales

- **Persistencia de brechas territoriales:** listas de espera mayores en regiones extremas.
- **Desigualdades en recursos humanos:** déficit de médicos especialistas en zonas rurales.

- **Brecha digital en salud:** acceso desigual a telemedicina y ficha electrónica.
- **Gasto de bolsillo elevado:** genera barreras económicas para tratamientos.
- **Migración y diversidad cultural:** nuevos desafíos de equidad e inclusión.

Pronóstico:

La equidad será el eje estructurante del nuevo modelo sanitario chileno 2030, con fortalecimiento de la APS, salud digital inclusiva y enfoque intersectorial basado en determinantes sociales.

9. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2024). Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.
 - Superintendencia de Salud (2023). Informe de brechas de equidad sanitaria.
 - OPS/OMS (2022). Equidad en salud y determinantes sociales en América Latina.
 - DEIS – MINSAL (2024). Indicadores sanitarios nacionales.
 - Ley N.º 20.850 (2015). Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.
-

10. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. **Equidad en salud** es el principio rector que busca eliminar diferencias injustas y evitables en salud.
2. Se diferencia de **igualdad**: equidad asigna recursos según necesidad, no de forma uniforme.
3. En Chile, las principales brechas son **socioeconómicas, territoriales y culturales**.
4. Las políticas **GES**, **Ley Ricarte Soto** y la **Atención Primaria Integral** son herramientas de equidad.

5. El **médico general** debe identificar barreras de acceso y actuar como promotor de justicia sanitaria.
6. La **equidad financiera** garantiza protección a los más vulnerables mediante subsidios y gratuidad.
7. El futuro del sistema chileno apunta a una **cobertura universal con enfoque de equidad territorial y social**.